



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

MESURER

& AMÉLIORER LA QUALITÉ

RAPPORT DE CERTIFICATION

APHM-HOPITAL DE LA CONCEPTION

147 boulevard baille
13005 Marseille



Validé par la HAS en Novembre 2024

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr



Haute Autorité de santé – Service communication et information
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00
© Haute Autorité de santé – Novembre 2024

Sommaire

Préambule	4
Décision	7
Présentation	8
Champs d'applicabilité	9
Résultats	10
Chapitre 1 : Le patient	11
Chapitre 2 : Les équipes de soins	14
Chapitre 3 : L'établissement	18
Table des Annexes	23
Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche	24
Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2024	25
Annexe 3. Programme de visite	29

Préambule

La certification, mission confiée à la Haute Autorité de Santé (HAS) par les ordonnances de 1996, est une procédure d'évaluation externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des professionnels (des pairs) mandatés par la HAS : les experts-visiteurs. Cette procédure quadri-annuelle, indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle, porte sur le niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés aux patients. Obligatoire, elle est codifiée à l'article L6113-3 (et suivants) du code de la santé publique.

La certification constitue une des modalités de mesure de la qualité des soins en établissements de santé et vise l'appropriation des standards de la qualité par les établissements. Elle y favorise également la mise en œuvre d'une dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Elle est une certification globale et non une certification de toutes les activités de l'établissement. En effet, le dispositif porte sur le fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à évaluer spécifiquement le fonctionnement de chaque secteur d'activité.

Elle fournit une évaluation de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé aux usagers et aux Agences régionales de santé (ARS) sans se substituer aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire menés par ces autorités de tutelle.

Cette démarche nationale est réalisée selon des standards internationaux : la procédure de certification est elle-même évaluée par l'International Society for Quality in Health Care via l'International Accreditation Program (IAP), le seul programme international qui accrédite les organismes qui accréditent des structures de soins. La HAS a obtenu de l'ISQua en 2018 le renouvellement de son accréditation pour son activité de certification.

Une évaluation qui s'appuie sur un référentiel élaboré par la HAS en concertation avec les professionnels de santé, les organisations représentatives et les représentants des usagers...

Chaque établissement de santé est évalué sur les critères génériques, s'appliquant à tout l'établissement, ainsi que sur des critères spécifiques relevant :

- de populations spécifiques : enfant et adolescent, patient âgé, personne en situation de handicap,
- de modes de prise en charge spécifiques : ambulatoire, hospitalisation à domicile (HAD), SAMU-SMUR, urgences, soins critiques (soins continus, soins intensifs et réanimation)
- de secteurs d'activités spécifiques : chirurgie et interventionnel, maternité, psychiatrie et santé mentale, soins médicaux et de réadaptation (SMR), unité de soins de longue durée (USLD).

Ce référentiel, publié sur le site Internet de la HAS, comprend des critères ayant des niveaux d'exigence différents :

- des critères standards correspondent aux attendus de la certification;
- des critères impératifs correspondent à ce que l'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Ils ont un impact particulier dans la décision de certification. En effet, si une évaluation de l'un de ces critères est négative pour un ou plusieurs de ses éléments d'évaluation, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement.
- des critères avancés correspondent à des exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour. Ils correspondent potentiellement aux critères de certification de demain et sont valorisés pour les établissements qui peuvent y répondre sous condition d'un niveau minimal sur l'ensemble des critères standards et impératifs.

| ... et sur des méthodes

- des patients traceurs pour évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge d'un patient dans l'établissement de santé
- des parcours traceurs pour évaluer la continuité et la coordination de la prise en charge des patients, le travail en équipe et la culture qualité et sécurité au cours d'un parcours de soins défini
- des traceurs ciblés pour évaluer la mise en œuvre d'un processus ciblé
- des audits systèmes pour évaluer les organisations de l'établissement et s'assurer de leur maîtrise sur le terrain
- des observations pour évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité des soins.

| Un rapport de certification structuré en 3 chapitres

Les résultats des évaluations réalisées durant une visite de l'établissement par des experts-visiteurs se traduisent dans un rapport de visite articulé en cohérence avec les 3 chapitres du référentiel.:

- Le premier chapitre concerne directement le résultat pour le patient. Tout au long de sa prise en charge, ses droits sont respectés, ses besoins spécifiques pris en compte de la même façon que ses attentes et ses préférences. Au-delà, l'engagement du patient est recherché. Son implication comme partenaire de sa prise en charge, tout comme celle de ses proches et aidants, est favorisée par l'expression de son point de vue sur son expérience et le résultat des soins.
- Le deuxième chapitre concerne les équipes de soins, à tous les niveaux. La certification vise à apprécier leur capacité à rechercher la pertinence, l'efficacité et la sécurité des soins, à se concerter et se coordonner tout au long du parcours du patient. Elle met également l'accent sur la maîtrise des risques liés au soin. Les analyses des événements indésirables associés aux soins, notamment les événements indésirables graves ainsi que des rapports de certification précédents conduisent à mettre un accent particulier sur le risque infectieux et le risque lié aux médicaments.
- Le troisième chapitre concerne l'établissement et sa gouvernance (direction et commission/conférence médicale d'établissement). Cette dernière favorise l'insertion territoriale en lien avec les autres acteurs de l'offre de soins et médico-sociale. Elle impulse une dynamique forte d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui associe et soutient les équipes, ainsi que les patients, représentants d'usagers et associations de malades.

Cette structuration permet l'analyse croisée entre le résultat pour le patient, les pratiques mises en œuvre par les équipes de soins et la dynamique impulsée par la gouvernance de l'établissement et du groupement, le cas échéant.

| Une décision et un rapport rendus publics

Sur la base du rapport de visite, complété d'éventuelles fiches d'anomalies et des observations de l'établissement, la HAS adopte le rapport de certification et rend une décision. La HAS peut prononcer trois types de décision :

- une décision de certification valable quatre ans qu'elle peut assortir d'une mention ;
- une décision de non-certification impliquant la mise en œuvre d'une nouvelle procédure dans un délai maximum de deux ans ;
- une décision de certification sous conditions ; une nouvelle procédure est alors programmée dans un délai compris entre six et douze mois. À l'issue de cette seconde procédure, la HAS constate si l'établissement a rempli les conditions pour être certifié. Elle prononce alors une décision de certification, avec ou sans mention, ou une décision de non-certification.

Le rapport et la décision sont publiés sur le site Internet de la HAS et communiqués à l'autorité de tutelle de l'établissement.

L'établissement doit en assurer la plus large diffusion interne. Il doit notamment la porter à la connaissance des instances délibérantes, de la commission ou conférence médicale d'établissement et de la commission des usagers.

Ce rapport de visite est produit par l'équipe des experts-visiteurs dans un délai d'une quinzaine de jour après la fin des évaluations et de la réunion de restitution, il est transmis à l'établissement pour que celui-ci puisse formuler ses observations. Il sera remis également à la HAS et fera partie des éléments de référence pour l'élaboration du rapport de certification

Décision

Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé décide la certification de l'établissement avec mention.

Présentation

APHM-HOPITAL DE LA CONCEPTION	
Adresse	147 boulevard baille 13005 Marseille cedex 5 FRANCE
Département / Région	Bouches-du-Rhône / Provence-Alpes-Côte d'Azur
Statut	Public
Type d'établissement	Centre Hospitalier Universitaire

Établissement(s) juridique(s) rattaché(s) à cette démarche (la liste des établissements géographiques se trouve en annexe 1)

Type de structure	N° FINESS	Nom de l'établissement	Adresse
Établissement juridique	130786049	ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE	80 rue brochier 13005 Marseille 05eme FRANCE

Synthèse des activités réalisées par l'établissement au 2024

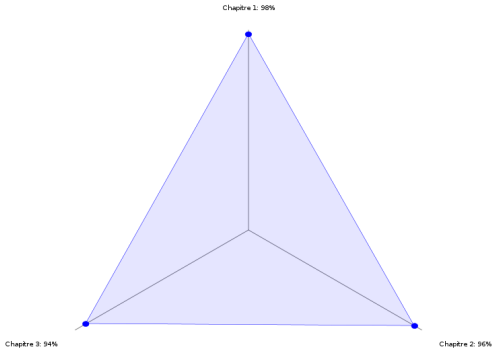
Vous trouverez en annexe 2 l'ensemble des activités réalisées par l'établissement.

Champs d'applicabilité

Champs d'applicabilité
Adulte
Ambulatoire
Chirurgie et interventionnel
Enfant et adolescent
Hospitalisation à domicile
Hospitalisation complète
Maladie chronique
Maternité
Médecine
Pas de situation particulière
Patient âgé
Patient atteint d'un cancer
Patient en situation de handicap
Patient en situation de précarité
Programmé
Psychiatrie et santé mentale
Soins critiques
Tout l'établissement

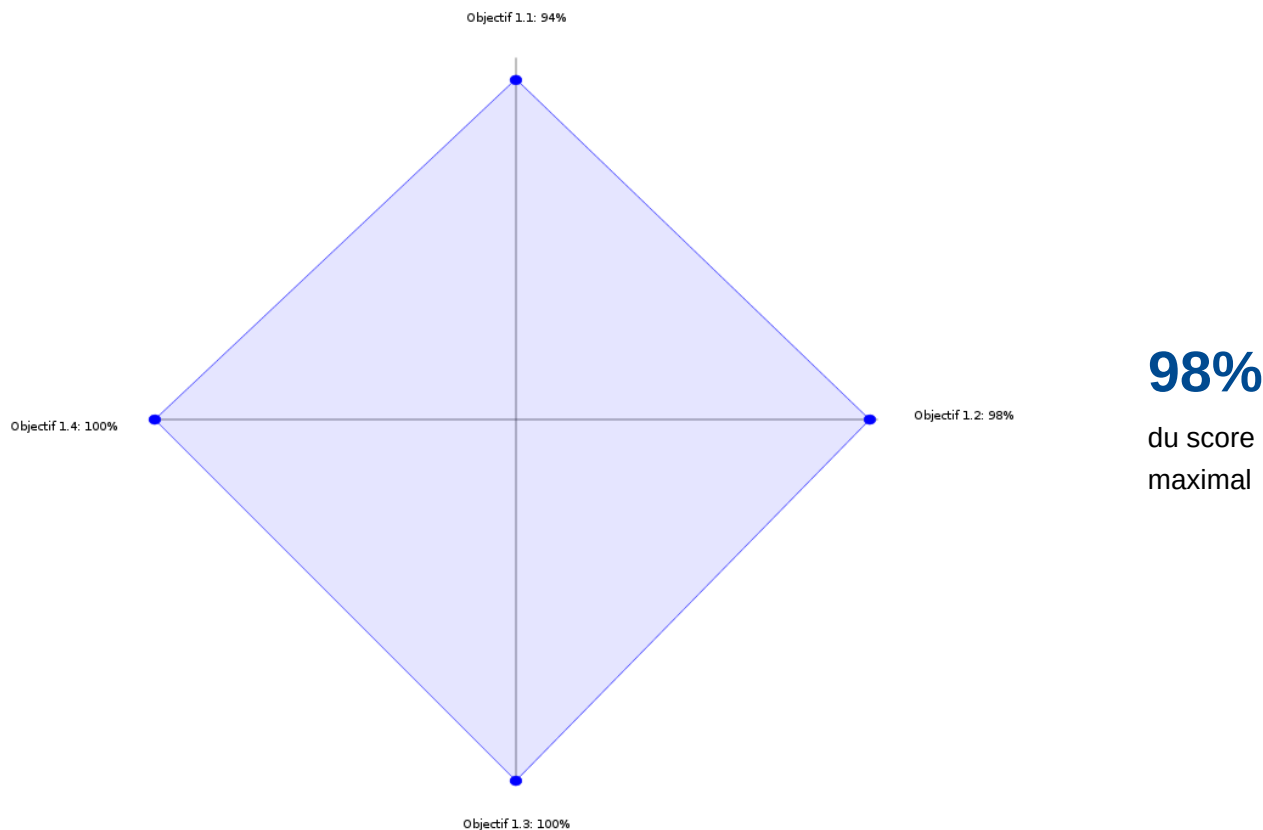
Au regard du profil de l'établissement, [124](#) critères lui sont applicables

Résultats



Chapitre	
Chapitre 1	Le patient
Chapitre 2	Les équipes de soins
Chapitre 3	L'établissement

Chapitre 1 : Le patient



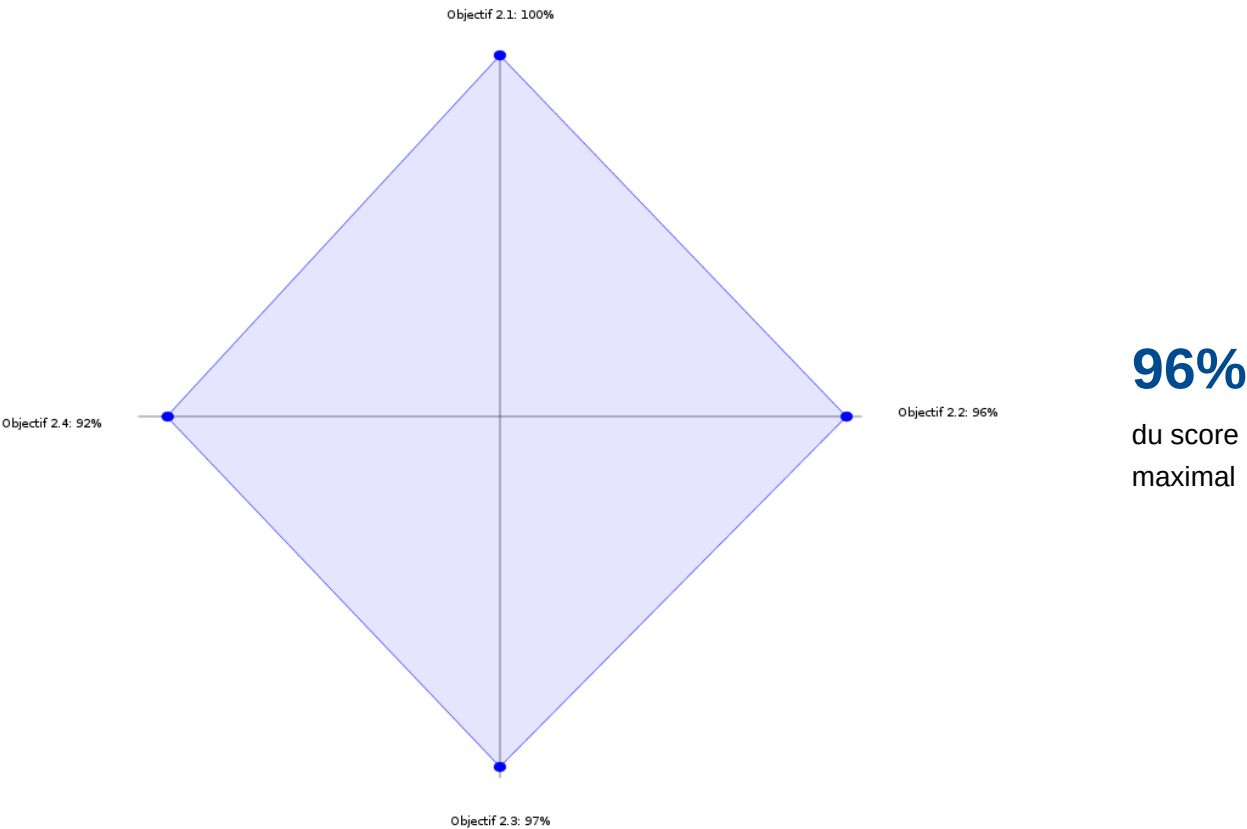
Objectifs		
1.1	Le patient est informé et son implication est recherchée.	94%
1.2	Le patient est respecté.	98%
1.3	Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient	100%
1.4	Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge	100%

L'hôpital de la Conception est l'un des quatre sites de l'APHM avec l'hôpital de la Timone, l'hôpital Nord et l'hôpital Sud ; il comprend un pôle mère-enfants et des lits d'hospitalisation adultes (ambulatoires et conventionnels) pour des secteurs de médecine, de chirurgie et de psychiatrie et d'HAD. L'APHM a décliné sa politique de droits du patient et de prise en charge au niveau de la Conception Tous les patients rencontrés dans tous les secteurs investigués ont reçu une information claire et adaptée à leur degré de discernement sur leur état de santé, les hypothèses et confirmations diagnostiques, ainsi que les soins prodigués. Pour se faire, les équipes ont développé des modalités différentes pour garantir une adhésion voire une alliance au projet de soins, comme par exemple l'information individuelle pré greffe et la réunion d'information collective obligatoire pour les patients candidats à la greffe ; le passeport en chirurgie plastique.... Dans ce cadre l'expression du

consentement libre et éclairé est facilitée. Certaines équipes de l'hôpital de la Conception accueillent des enfants et veillent à adapter les modalités de communication à l'âge de l'enfant, au-delà des informations données aux parents. Le patient bénéficie de messages renforçant sa capacité à agir pour sa santé, comme en HAD adulte et HAD maternité-enfants (formation des parents à l'administration des médicaments, formation des aidants aux soins à réaliser à domicile), en psychiatrie sous la forme d'ateliers (hygiène corporelle et dentaire, sexualité, sommeil), en endocrinologie avec de nombreux supports d'information sur la prévention primaire (activités sportives, alimentation et diabète ou hypercholestérolémie...), en HDJ psychiatrie et en CATTP grâce à des réunions communautaires pluri professionnelles qui permettent d'aborder des questions de santé publique en lien avec les difficultés de la vie quotidienne et l'addiction, avec l'intervention d'associations. Les patientes de PMA bénéficient systématiquement d'une consultation en santé environnementale. Le patient bénéficie d'actions pour devenir acteur de sa prise en charge (exemple : bébé en mousse utilisé en complément d'un livret illustré pour les soins de nursing ou prise de médicaments en néonatalogie ; surveillance du Ph pour les patients sous méthotrexate ; travail sur l'allaitement et le « peau à peau » avec des référentes et groupes mis en place sur le retour à la maison, le portage, la prématurité, la souffrance du bébé). Des infirmières de pratiques avancées et les IDE coordonnatrices participent à ces activités dans différents secteurs (pour exemple : ETP post greffe par IDE coordinatrice). Enfin des programmes d'éducation thérapeutique sont proposés aux patients en endocrinologie, néphrologie avec la dialyse ou encore en oncohématologie. En maternité, la rédaction d'un projet de naissance est proposée aux parents. Cette information est tracée dans le dossier. Le livret d'accueil papier est disponible aux bureaux des entrées du site et en service de soins. Dans certains secteurs (dialyse, psychiatrie par exemple), un livret d'accueil spécifique est remis aux patients. Les affiches avec un QRcode renvoient vers le livret dématérialisé et sont présentes dans les services et dans les chambres des patients ; pour autant certains patients rencontrés n'ont pas eu un livret d'accueil et ne se sont pas encore emparés de cette modalité QR code. Par ailleurs les patients ne sont pas toujours informés de leur droit à demander que le DMP et mon espace santé ne soient pas alimentés et ils ne savent pas toujours qu'il ne doit pas y avoir d'échanges avec les équipes par une messagerie non sécurisée. Le patient, en prévision de sa sortie, est informé des consignes de suivi pour sa prise en charge. Un carnet de liaison est en place en dialyse, à l'image d'un carnet de santé pour partager des informations entre le patient et les professionnels de santé qui le prennent en charge. Un pharmacien assure un suivi du patient rentré à domicile vis-à-vis de la survenue d'éventuels effets secondaires en onco-hémato, par un appel à J7 puis à 1 mois après la sortie. En ambulatoire, le patient reçoit les informations spécifiques aux modalités de sa prise en charge. En chirurgie ambulatoire, un passeport est remis au patient avec des appels à J-5, J-1 et l'appel du lendemain. Pour autant, il n'est pas toujours retrouvé de document d'informations spécifiques remis au patient à sa sortie en HDJ PSY. Le patient est informé des dispositifs médicaux qui lui sont implantés durant son séjour et reçoit les consignes de suivi appropriées ; l'identification et l'information du patient sont majoritairement tracées dans la lettre de liaison. Le patient peut désigner la personne à prévenir et la personne de confiance de son choix, dont la trace est retrouvée dans le dossier. Au sein des services prenant en charge des nouveau-nés, une « personne ressource » est proposée pour aider les parents, et être là pour l'enfant. Les directives anticipées sont bien abordées dans les plaquettes d'information et un formulaire présent dans le dossier « type » du patient. Outre les patients rencontrés en oncohématologie, les patients sont peu informés sur leur droit à en rédiger et les équipes de soins informent peu le patient sur ce droit. Le patient a la possibilité, en situation de fin de vie, de faire valoir au plus tôt sa décision d'accéder aux soins palliatifs, quel que soit le service accueillant le patient. Une démarche palliative pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, coordonnée et protocolisée est mise en œuvre pour les patients en fin de vie, avec possibilité de mobiliser, H24, l'équipe mobile de soins palliatifs de l'APHM. Plus spécifiquement, dans le cadre de la prise en charge de l'accompagnement de fin de vie de nouveau-nés, des modalités de prise en charge ont été travaillées avec l'équipe mobile de l'AP-HM. Les affichages des chartes sont présents et adaptés aux services concernés. Mais en dépit des affichages et communication sous différentes formes des représentants des usagers (adresse mail par exemple ; QR Code ; plaquette avec trombinoscope), les patients rencontrés connaissent peu les

représentants des usagers et associations de bénévoles qui peuvent les accompagner et leur rôle. Le patient bénéficie dans tous les secteurs de la garantie du respect de ses droits. Il bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité ; il a été constaté dans tous les secteurs d'activité des pratiques respectueuses (utilisation de pyjama tissé non transparent pour les patients arrivant debout aux blocs opératoires), toujours exprimées par les patients, parfois en dépit de locaux inadaptés en termes de confort (exemple : pas de salle de bain adaptée dans le service avec nécessité de conduire les patients dans le service voisin) et de sécurité (marche dans la douche dans les chambres de néphrologie). Une rénovation d'unités d'hospitalisation est planifiée pour 2025 avec un regroupement des activités ambulatoires d'endocrinologie et un déplacement de l'unité de chirurgie ambulatoire (UCA). Il existe des paravents dans tous les services, mais pas dans toutes les chambres doubles. En raison d'un manque de place, les équipes disposent de paravents mobiles, à installer selon les besoins et les demandes des patients. Le patient bénéficie du respect de la confidentialité des informations le concernant (exemple : pour les chambres à deux lits, proposition faite au patient de réaliser les entretiens dans une autre pièce en neurologie). Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient. Ils peuvent s'impliquer dans la mise en œuvre du projet de soins. Leur présence est grandement facilitée en dehors des heures de visite lorsque la situation le nécessite (réponse personnalisée aux demandes des proches, présence H24 des parents en réanimation). Des mineurs peuvent être pris en charge dans des secteurs adultes et bénéficient dans ces cas-là d'un environnement adapté. Le patient vivant avec un handicap bénéficie du maintien de son autonomie tout au long de son séjour. Lors des consultations médicales en amont de l'hospitalisation, les facteurs de vulnérabilité du patient sont relevés et pris en compte dès son arrivée. Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur. De nombreux protocoles sont mis en œuvre, les échelles de douleur sont partout adaptées à la typologie des patients, avec par exemple l'échelle minoPAIN développée par La Conception et utilisée par toute l'AP-HM, pour évaluer l'inconfort des nouveau-nés. Cet outil participe également à l'éducation des parents pour évaluer, à domicile, la douleur de leur bébé. Le recours à la contention mécanique fait l'objet d'une décision médicale, motivée, tracée et réévaluée ; il est constaté une politique médicale de limiter au maximum le recours à cette contention mécanique avec une recherche de solutions alternatives, notamment en psychiatrie (environnement adapté, inclusion de la famille, soutien psychologique en oncologie). Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge. Le patient en situation de précarité bénéficie du service social de l'établissement et d'un accompagnement pour une orientation vers les services sociaux et associations adéquates. En maternité, les patientes sont accompagnées en fonction de leurs besoins et attentes : lien avec la PMI ou l'unité mobile de périnatalité ; prise en charge par la Maison des Femmes ou la PASS maternité-enfant. Un suivi à domicile des nouveau-nés vulnérables est organisé avec une équipe mobile enfant vulnérables. En endocrinologie, pour les adolescents pris en charge pour trouble du comportement alimentaire, des ateliers sont proposés par la psychologue. En psychiatrie, des activités thérapeutiques sont proposées aux patients et pour les patients jeunes après un premier épisode psychotique, un lien est mis en place avec le CLIP (cellule locale d'intervention précoce). Un groupe gynéco-psychiatre se réunit mensuellement et permet aux patientes d'exprimer leurs difficultés et d'avoir un avis. Le patient vivant avec un handicap ou ses proches et aidants exprime ses besoins et préférences pour une prise en compte dans son projet de soins ou pour une orientation vers une unité adaptée (pour exemple : Consultation pour sourds et malentendants à l'unité de surdité et santé mentale méditerranéenne). Les conditions de vie habituelles sont prises en compte notamment pour la préparation de la sortie (exemple : en chirurgie ORL, suivi à domicile par IDE responsable de la RAAC à J1, J4, J10, J15 ; suivi à domicile par un réseau IDE libérales formées à la manipulation des dispositifs chez les trachéotomisés, expérimentation du dispositif perMAT avec des visites à domicile de sage femmes libérales).

Chapitre 2 : Les équipes de soins



Objectifs		
2.1	La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée au sein de l'équipe	100%
2.2	Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge	96%
2.3	Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques	97%
2.4	Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle	92%

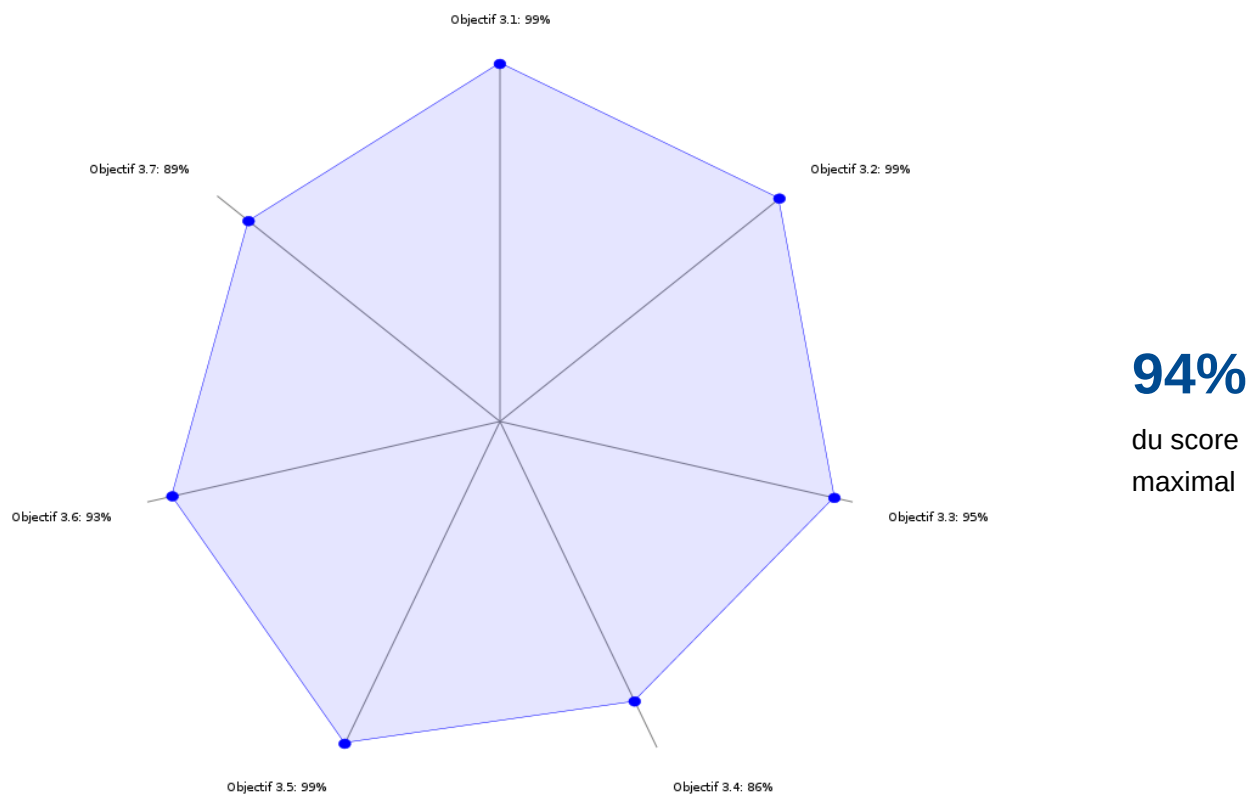
Un travail de pertinence des parcours a été réalisé à la fois au niveau de l'APHM, de l'Hôpital de la Conception, mais aussi au niveau du GHT13 (quinze filières médicales définies et déployées avec les autres établissements, des actions de proximité avec des animations par l'APHM de maisons médicales de santé). La pertinence des actes et des prescriptions est également argumentée au sein des équipes. La pertinence des décisions de prise en compte s'appuie sur des protocoles actualisés adossés aux recommandations de bonnes pratiques ; des réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) sont mises en place dans plusieurs secteurs d'activité soit au niveau de l'établissement, soit avec d'autres structures publiques. Il existe deux filières en HAD, adulte et maternité-enfants à l'Hôpital de la Conception. Le recours à l'HAD est coordonné avec d'autres sites de l'APHM et partenaires de ville. L'HAD intervient sur l'intégralité du parcours. La prescription d'une HAD

est envisagée dans le cadre du projet de soins, notamment dès l'admission du patient en court séjour gériatrique (exemple : l'Hôpital de la Conception ou réseau soins palliatifs Bouches-du-Rhône). La pertinence des prescriptions d'antibiotiques est argumentée et réévaluée. Les recommandations de bonnes pratiques actualisées sont facilement accessibles à partir du dossier informatisé du patient. Des livrets adultes et enfants ont été remis à jour avec l'aide du référent antibiothérapie. La traçabilité de la réévaluation à 7 jours est effective. La pertinence de la transfusion de produits sanguins labiles est argumentée (dossier transfusionnel entièrement dématérialisé incluant prescription, surveillance, facteurs de risque, incidents, étapes non réalisées). La sécurité transfusionnelle est assurée avec un programme de formation, pour chaque étape de la transfusion, basé sur les protocoles à jour. Les modalités de transport sont définies pour chaque service en fonction de ses besoins. Le taux de destruction est suivi. Le patient est informé des produits sanguins labiles qui lui sont administrés. Les équipes se coordonnent de façon pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle tout au long de la prise en charge du patient, au sein du site et en faisant appel à d'autres équipes hors site. Les professionnels tracent en temps utile leurs interventions sur le dossier patient. Cependant, l'ergonomie du système d'information limite parfois l'accès simultané à l'ensemble du dossier patient utile à la prise en charge, comme en dialyse, en psychiatrie, ou au bloc opératoire. L'établissement est engagé dans le déploiement d'un dossier patient informatisé commun pour l'ensemble de ses activités. La coordination entre équipes est assurée grâce à de nombreux staffs pluriprofessionnels et à de nombreuses RCP. Les équipes se coordonnent aussi dans le cas où le patient n'a pas été orienté dans l'unité adaptée faute de disponibilité. Cependant, l'hébergement de patientes de maternité en service de chirurgie limite l'accompagnement à la parentalité (peu de disponibilité de l'équipe ; pas de lit accompagnant). L'équipe de soins peut faire appel si besoin à un réseau d'équipes de recours ou d'expertise : équipes mobiles de gériatrie, psychiatrie, douleur, infections, soins palliatifs, hygiène et équipes des centres de référence ou compétences des maladies rares. En onco-hémato, la prise en charge des patients prend en compte les risques et besoins, en fonction des tranches d'âge spécifiques (18 / 25 ans = RCP adolescents et jeunes adultes tous les 15 jours avec une IDE AJA présente lors de la 1ère hospitalisation et pour les personnes âgées, recours à l'oncogériatrie de Ste Marguerite ou à l'équipe mobile de gériatrie). Les acteurs de la programmation opératoire sur les différents blocs se coordonnent et tiennent compte de la priorisation des urgences. Un staff hebdomadaire analyse les déprogrammations et les délais de reprogrammation. Au sein des blocs de l'Hôpital de la Conception, la check List « sécurité du patient » est utilisée. Néanmoins cette check List n'est pas toujours réalisée en présence des personnes concernées (étape 3) ; un audit réalisé en 2024 a montré des améliorations en lien avec les actions définies à l'issue de l'audit mené en novembre 2023. L'interface avec la biologie médicale, le service d'anatomopathologie et l'imagerie est opérationnelle et adaptée aux besoins (pour exemple : astreinte d'anatomopathologie pour extemporanée sur greffon rénal suspect 24/24h). En phase de transition adolescent-adulte, les équipes se coordonnent pour assurer la continuité de la prise en charge du patient. Par exemple, une consultation commune en endocrinologie entre les secteurs pédiatrique et adulte, la transition enfant-adulte en dialyse, ou encore la coordination entre pédopsychiatrie de Sud avec les équipes "adultes" de l'Hôpital de la Conception sont organisées. Le carnet de santé, le dossier du patient et le dossier médical « mon espace santé » (DMP) sont majoritairement mis à jour de manière synchronisée pour assurer la continuité des soins avec la ville. L'équipe du Centre d'accueil permanent (CAP48), située sur le site de la Timone, permet d'améliorer la régulation des urgences psychiatriques. Elle a accès aux données du patient et oriente le patient dans le circuit adapté à sa prise en charge, en organisant le transfert sur le site de l'Hôpital de la Conception de façon sécurisée. Les équipes de psychiatrie suivent les délais d'entrée en soins (pour les patients qui ne dépendent pas du secteur, RDV dans les 15 jours avec IDE et 3 semaines avec un médecin). La prise en charge en psychiatrie intègre un examen somatique dans les meilleurs délais après son hospitalisation. L'examen est réalisé à l'entrée par l'interne de médecine générale, validé par le généraliste du pôle (0,5 ETP). Le recours à des avis spécialisés est facilité. Un groupe gynéco-psychiatrique se réunit 1 fois par mois et permet aux patientes d'exprimer leurs difficultés et d'avoir un avis. Une lettre de liaison à la sortie est remise au patient et permet la continuité du parcours de soins. Cependant, le bilan thérapeutique n'est pas systématiquement

retrouvé dans la lettre de liaison ou le compte-rendu d'hospitalisation. Les équipes respectent les bonnes pratiques d'identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge (lieux adéquats, professionnels formés, bracelet d'identification pour tous les patients même en dialyse et HDJ ONCO). En cas de doute sur un doublon ou une erreur d'identité, les professionnels ont la possibilité d'envoyer un mail à la cellule d'identitovigilance, prérempli avec l'IPP du patient, via le dossier patient. Pour les secteurs de psychiatrie, pendant la visite, la procédure d'identitovigilance des patients a été mise à jour pour intégrer la nouvelle modalité d'identification des patients de ces services par un bracelet. Les équipes connaissent et appliquent les modalités de gestion des vigilances sanitaires qui concernent le site. La politique de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse APMH est portée par le COSEPS (comité de sécurisation des produits de santé) ; ce comité se décline en plusieurs groupes de travail pluridisciplinaires. La PUI est gérée à l'échelle de l'APMH avec deux services transversaux (service central de la qualité et de l'information pharmaceutique et le service central des opérations pharmaceutiques) et les activités pharmaceutiques réalisées sur chaque site dont l'Hôpital de la Conception. La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient sur le site de l'Hôpital de la Conception bénéficie d'activités de pharmacie clinique (entretiens avec les patients greffés rénaux et anticipation de la mise à disposition du traitement à domicile en lien avec l'officine du patient ; entretien avec les patients en onco-hématologie en HC ou HDJ pour les traitements de chimio orale ; participation du pharmacien aux RCP et au programme d'ETP animé mensuellement) et de la conciliation médicamenteuse (conciliation pro active en endocrinologie). De façon très générale, sur l'Hôpital de la Conception, le circuit du médicament est sécurisé et adapté aux besoins. L'analyse pharmaceutique de niveau 3 est réalisée pour tout patient entrant ; cependant cette analyse n'intègre pas les éléments du dossier pharmaceutique du patient (ordre des pharmaciens/assurance maladie). L'avis pharmaceutique est délivré par téléphone pour les prescriptions de psychiatrie et un pharmacien est présent en néonatalogie. Les équipes respectent les bonnes pratiques d'administration des médicaments (utilisation d'étiquettes institutionnelles pour les injectables, préparation des médicaments au plus près de l'administration, traçabilité de l'administration). En HAD, l'enregistrement de l'administration est assuré sur le logiciel institutionnel et les équipes ont accès aux données patients au domicile, que les IDE soit APMH ou libérales. Les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque. Le transport des médicaments est sécurisé sur le site et dans le cadre de la filière HAD. Les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie. La Rétrocession de l'AP-HM est réalisée sur le site de l'Hôpital de la Conception, qui a mis en place un circuit logistique permettant d'acheminer le traitement de rétrocession des patients dans leur officine, via les grossistes répartiteurs. Ce dispositif a permis de garantir la continuité pharmaceutique sur toute la période COVID et se poursuit aujourd'hui car il a montré une amélioration notable dans le parcours de soin des patients. Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes pratiques d'hygiène des mains (connaissance et suivi de l'ICSHA dans la plupart des services), ainsi que les précautions standard et complémentaires. Le CLIN et l'EOH assurent la formation des professionnels, la gestion des excréta, la surveillance des ISO et gèrent les alertes BMR et BHRE. Des audits ont lieu régulièrement sur certaines thématiques (exemples : hygiène des mains, zéro bijou, dispositifs invasifs, etc). Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liés aux actes invasifs et disposent de protocoles adaptés à chaque chirurgie, qui sont consultables dans chaque salle de bloc. Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au circuit des dispositifs médicaux invasifs. Des fibroscopies, des cystoscopies et des endoscopies (urologie, CGS, ORL, aux blocs opératoires/SSPI et réanimation des brûlés) sont réalisées au sein de l'Hôpital de La Conception. Des cystoscopes à usage unique et des fibroscopes à usage unique et réutilisables sont utilisés. Les processus de traitement et désinfections sont maîtrisés (double lingette et/ou immersion). La formation aux pratiques de traitement des endoscopes des professionnels est assurée sur le site de l'Hôpital de la Timone (2 jours suivis d'une évaluation). Des prélèvements de microbiologie sont réalisés une fois par an par la technicienne hygiéniste. Pour les jours non ouvrables et la nuit, un chariot endoscopie en ORL est prévu. Le parc des endoscopes est inventorié et suivi avec l'ingénieur biomédical et l'EOH. La vétusté globale des salles du blocs opératoires et des zones de stockage insuffisantes rendent difficile le nettoyage du bloc opératoire. Le

site est conscient de cette difficulté. En attendant la réhabilitation du bloc central, incluse dans le projet UCA/BO/OPH dont les travaux ont débuté et devraient se terminer en 2027, des contrôles sont organisés : contrôle des paramètres aérauliques des salles réalisé en août 2023 avec des résultats conformes et des prélèvements bactériologiques air/surfaces réalisés annuellement. Une surveillance des ISO est en place en urologie et chirurgie plastique avec, en 2023, des résultats conformes à l'attendu. Les équipes pluriprofessionnelles maîtrisent le risque de dépendance iatrogène. Les équipes respectent les recommandations et obligations vaccinales pour les professionnels de santé. Une sensibilisation est réalisée par affichage, l'encadrement, et le service de la médecine du travail, au sein des services et au self. Les équipes maîtrisent les risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants ; cependant le patient n'est pas toujours informé des doses reçues. Pour exemple, les mobiles utilisés en réanimation sont reliés au PACS mais en l'absence de compte rendu d'examen, la dosimétrie n'est pas communiquée au patient. En réanimation néonatale, l'équipe a travaillé sur la pertinence des radiographies de poumons avec l'adaptation paramétrage des appareils de façon à diminuer au maximum les doses de rayonnement. Les équipes maîtrisent le risque lié à l'hémorragie du post-partum (HPPI). Les équipes sont formées (en e-learning, in-situ par les médecins du service et avec le réseau périnatal). Les embolisations sont réalisées si besoin à l'Hôpital de la Timone sur la base d'un circuit formalisé entre les deux équipes et le SAMU. Par ailleurs, l'organisation en place pour assurer la prise en charge des césariennes la nuit a été revue en visite de certification afin de pourvoir les vacations laissées vacantes et de renforcer la maîtrise du risque. Enfin, l'organisation d'une des salles de naissance va être revue. L'autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire est validée sur la base d'un score. Le transport intra hospitalier des patients du site de l'Hôpital de La Conception est organisé avec une équipe de 39 brancardiers, régulée par une équipe dédiée, avec l'appui d'une solution logicielle. Les patients sont informés des destinations et des horaires. Les délais sont en adéquation avec la continuité de prise en charge. Des indicateurs sont suivis. En ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, la dynamique et la maturité des démarches sont hétérogènes dans les différents secteurs d'activité de l'Hôpital de la Conception. Peu d'équipes se fondent sur l'analyse de résultats cliniques et sont en capacité de mettre en place un plan d'actions. La majorité des équipes cherchent à améliorer leurs pratiques en se fondant sur le témoignage des patients, pour exemple, en maxillo-facial, l'analyse des questionnaires de satisfaction a permis d'augmenter la gamme de produits alimentaires BYC et le recueil de l'expérience patient a conduit à l'amélioration de la prise en charge de la douleur avec l'achat d'un matériel de réfrigération des pansements. La plupart des équipes améliorent leurs pratiques en se fondant sur leurs résultats d'indicateurs notamment les indicateurs qualité et sécurité des soins (exemple : en psychiatrie, indicateurs connus ayant donné lieu à des actions d'amélioration sur la prise en charge de la douleur, sur la consommation de SHA). La plupart des équipes améliorent leurs pratiques en analysant les événements indésirables associés aux soins qu'elles ont déclarés, de façon plus ou moins régulière avec des plans d'actions dans le PAQSS de l'Hôpital de La Conception, dont l'impact sur la maîtrise du risque est peu ou pas évalué. Toutes les équipes éligibles ne connaissent pas toujours le dispositif d'accréditation. Les équipes des soins intensifs tiennent à jour un registre de refus d'admission, cependant elles ne suivent pas les réhospitalisations à 48/72 heures. Les équipes des secteurs interventionnels (bloc central, bloc grands brûlés, bloc obstétrical) améliorent leurs pratiques en analysant les modalités de réalisation de la check List (analyse des GO/No GO, suivi réalisé ou initié dans certains secteurs d'indicateurs de pratiques et d'utilisation).

Chapitre 3 : L'établissement



Objectifs		
3.1	L'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire	99%
3.2	L'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement	99%
3.3	La gouvernance fait preuve de leadership	95%
3.4	L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences	86%
3.5	Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance	99%
3.6	L'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté	93%
3.7	L'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins	89%

L'AP-HM est l'établissement pivot du système de santé régional. Il se compose de quatre sites (Hôpital de la Timone, Hôpital Nord, Hôpital Conception et Hôpital Sud), 25 pôles d'activités médicales et 250 services (au total 3300 lits et places), 93 centres labellisés « Maladies rares », un centre d'enseignement et de recherche avec l'Institut Méditerranée Universitaire (infectiologie) et trois centres de recherche hospitalo-universitaires, 13

instituts de formation, 3 centres de santé (Aygaldes, Flamants et Aubagne), une maison des femmes à Marseille. L'AP-HM est établissement support du GHT 13 et a été en 2023 à l'initiative d'un projet stratégique de territoire, avec la mise en œuvre des postes partagés en médecine et en chirurgie pour favoriser le développement de filières (par exemple la filière gériatrique avec les établissements médico-sociaux) et conforter son attractivité. L'établissement a également tissé des liens avec les cliniques et la médecine de ville. Il est le premier employeur de la région PACA avec 3000 professionnels médicaux et 13000 professionnels non médicaux. La stratégie en politique de santé, en politique des ressources humaines et en maîtrise des risques est élaborée au niveau central et déclinée sur chaque site. Le site de l'Hôpital de la Conception comporte 800 lits adultes (soit 22,6% de l'AP-HM), avec une activité d'obstétrique (2 778 naissances – maternité de niveau 3), une activité médicale et chirurgicale adultes (23 030 entrées en hospitalisation complète, 374 000 consultations et actes techniques, 12 587 interventions au bloc) et une activité de psychiatrie adulte. Dans son plan de modernisation « Cap sur 2030 », l'AP-HM donne à ce site des ambitions à 10 ans, se traduisant par un projet de rénovation et de densification du site de l'Hôpital de la Conception pour accompagner le maintien de l'offre de soins, à travers 5 objectifs : optimiser le parcours en chirurgie ambulatoire, rénover des unités d'hospitalisation, réaliser des travaux de sécurisation, accueillir les activités de neurologie et ophtalmologie et rénover et étendre les salles de bloc. L'AP-HM a défini ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire. Elle participe aux projets territoriaux de parcours dans le cadre du GHT avec de très nombreuses filières organisées et une politique « d'aller vers » les établissements médico-sociaux et la médecine de ville (commission ville-hôpital, collaboration entre pédiatrie et équipe de liaison de pédopsychiatrie). Elle a des relations avec les cliniques avec une stratégie de débord pour les moments de tension dans les secteurs de soins critiques notamment. Elle participe à la coordination des parcours sur le territoire et hors territoire dans le cas d'activités de recours. L'Hôpital de la Conception est un établissement en « hyper centre », tourné vers le programmé et l'ambulatoire. Il s'inscrit dans son territoire au travers d'une forte dynamique volontariste de coopération avec différents acteurs et partenaires : sanitaires (deux autres structures publiques psychiatriques de Marseille ; postes partagés ou consultations avancées avec les établissements du GHT), avec les 10 CPTS et avec les structures médico-sociales. L'Hôpital de la Conception participe au projet de santé publique en interface avec la ville, à travers ces nombreux programmes d'éducation thérapeutiques et des modalités d'accueil et de prise en charge pour des publics spécifiques : siège du C S Obésité PACA ouest ; de l'unité de surdité santé mentale ; de consultations sourds et malentendants ; de 2 PASS (adultes et maternité) ; de la Maison des femmes ; du Centre gynécologie sociale ; d'un centre de dépistage du mélanome ; organisation d'un suivi des nouveau-nés fragiles à domicile . L'Hôpital de la Conception est également un établissement de recours pour d'autres CHU grâce à son centre de prise en charge des grands brûlés, sa maternité (niveau 3 avec un service de néonatalogie complet), son centre clinico-biologique d'AMP, son centre de dialyse lourd et de transplantations rénales, son centre de lithotritie et ses centres de références et compétences pour les maladies rares. Il contribue à prévenir les passages évitables des personnes âgées aux urgences générales, notamment en ayant recours à l'HAD. La prise en charge en psychiatrie à l'AP-HM dessert la population marseillaise de 6 arrondissements (du 13004 au 13010 inclus). Elle est organisée en un pôle monothématique et 6 services : 3 sont situés à l'Hôpital de la Conception, et 3 à l'hôpital Sud. L'accueil des urgences psychiatriques des différents secteurs pris en charge par l'Hôpital de la Conception est réalisé au CAP48 situé sur le site de La Timone. La spécialité assure des activités de proximité sectorisées (HC, HDJ, CMP, équipes mobiles) et de recours (centres experts, unités dédiées). L'AP-HM, établissement support du GHT Hôpitaux de Provence a été actif dans l'élaboration du PTSM de son territoire, en lien avec ses partenaires et interlocuteurs externes relevant du sanitaire, médico-social et du social. L'AP-HM, avec ses sites psychiatriques, dont l'Hôpital de la Conception, porte un contrat local de santé mentale pour travailler à limiter les ruptures de parcours et proposer des réponses adaptées. Une démarche offensive est menée en matière d'habitat. L'organisation en aval des urgences psychiatriques est analysée et travaillée avec les structures d'aval et des partenaires (Hôpital Sud, deux autres hôpitaux psychiatriques de Marseille) pour assurer la fluidité du parcours. Les modalités de communication permettent aux usagers et aux médecins de ville de contacter aisément

l'établissement (numéros directs, annuaire en cours, messagerie santé sécurisée déployée sur tout le site pour échanger avec les professionnels de santé, ou, le cas échéant une messagerie sécurisée en cours de généralisation). L'alimentation du DMP est suivie par des indicateurs, avec mise en place d'un plan d'amélioration de la performance. Cependant, les actions visant la maîtrise des usages non sécurisés d'échanges des données de santé n'ont pas donné lieu à un programme d'actions structuré formalisé. Par ailleurs, les professionnels ne connaissent pas toujours les types de documents du dossier patient reversés au DMP. L'établissement promeut la recherche clinique en son sein et en lien avec d'autres acteurs du territoire (structuration territoriale depuis 2022, plus de 2000 articles publiés par an, plus de 1900 programmes de recherche en cours, recherche paramédicale lauréate, association des établissements du GHT et du CLCC à certains programmes de recherche). Par ailleurs, il favorise l'accès aux innovations pour les patients (centres de compétences et de référence pour les maladies rares). L'AP-HM favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement. Cette volonté institutionnelle se traduit à l'Hôpital de la Conception par la promotion de nombreuses formes de recueil de l'expression du patient (exploitation des verbatims d'e-satis, développement d'enquêtes ou de questionnaires spécifiques à des secteurs d'activité). Quelques actions PROM'S sont également menées. Le site promeut des actions mobilisant l'expertise de patients experts formés à l'ETP, de patients pair-aidants dans le dispositif de l'équipe mobile de psychiatrie, d'anciens patients en néphrologie ou ORL/laryngologie ou en chirurgie bariatrique dans des vidéos d'information. L'impact des intégrations de l'expertise des patients n'est pas encore mesuré et les patients ne participent pas toujours aux démarches collectives de développement et d'amélioration des pratiques. L'Hôpital de la Conception a une communication centrée sur le patient (identification des professionnels, formation à la communication dans les situations de violence, exploitation des plaintes/réclamations). L'AP-HM a engagé une politique de bientraitance déclinée sur l'Hôpital de la Conception. Au-delà d'actions institutionnelles comme la charte de bientraitance, les formations ou vidéo sur intranet, des démarches sont menées pour accompagner le bien-être des patients (par exemple : en onco-hématologie, des activités différentes sont proposées pour lutter contre l'isolement des patients, telles que du coaching sportif, de l'ostéopathie, de la lecture ; en néonatalogie, les enfants peuvent venir visiter le service plusieurs années après leur naissance ; la filière « Hirschprung, antibiothérapie pour pyélonéphrites », qui évite aux enfants de longues attentes aux urgences a été mise en place ; l'équipe est renforcée lors de la prise en charge d'un enfant en fin de vie pour être plus disponible ; en endocrinologie TCA, il existe dans le service 2 chambres bariatriques équipées (lit adapté loué, chaise bariatrique, mobilier adapté, toilettes renforcées ...). L'Hôpital de la Conception participe au repérage et à la prise en charge des maltraitances éventuelles subies par les patients et lutte contre la maltraitance en son sein (circuits d'alerte connus des professionnels, outils de repérage, interventions du service social pour les patients vulnérables et des psychologues, Maison des Femmes). L'Hôpital de la Conception est attentive à l'accessibilité de ses locaux aux personnes vivant avec un handicap locomoteur et a associé un représentant des usagers porteur d'un handicap moteur à un audit mobilité, pour relever les difficultés et mettre en place des actions. L'Hôpital de la Conception prend en charge des patients très vulnérables et précaires. Des ressources et dispositifs sont connus des professionnels et mis en place pour favoriser l'accès aux soins de ces patients : intervention du service social, PASS adulte et PASS maternité-enfants, qui, après les premiers soins, font le lien avec des espaces de santé, des maisons de santé et des associations de proximité ; en maternité, le staff hebdomadaire médico psycho-social en maternité, le suivi des femmes sans droits sociaux par les sages femmes de la PMI après retour à domicile ; la possibilité de suivre à domicile les nouveau-nés vulnérables par une équipe mobile et la maison des femmes. A la PASS adulte, un pharmacien assure les premiers soins médicamenteux et un suivi notamment des patients chroniques. L'Hôpital de la Conception s'est organisé pour permettre au patient d'accéder rapidement à son dossier et travaille à l'amélioration des délais. L'Hôpital de la Conception implique les représentants des usagers et des associations de patients dans ses instances et dans la vie institutionnelle (une CDU à l'AP-HM et une commission locale des usagers sur chaque site, dont l'Hôpital de la Conception). Ces derniers sont impliqués dans des projets aux côtés des équipes et réalisent des visites de service. Un projet des usagers de l'AP-HM a été co-construit et se décline en 3 axes qui se traduisent par des actions

concrètes. La gouvernance de l'AP-HM fait preuve de leadership. Cette capacité à conduire les collectifs professionnels se déclinent au niveau de l'Hôpital de la Conception : politique qualité/sécurité déclinée en plans d'actions institutionnels et de secteurs d'activité, implication forte des instances, binômes cadre de santé et chef de service co-animateurs des démarches qualité/sécurité, tableaux de bord par services. Une majorité des professionnels rencontrés savent citer des actions du plan qualité en lien avec leurs activités. La culture de sécurité des soins est soutenue (évaluation de la culture sécurité au niveau des services avec un score annuel et un benchmarking par pôle et pour le site). L'adéquation ressources humaines/qualité-sécurité des prises en charge est pilotée. L'évolution des modes de prise en charge appelle à des adaptations organisationnelles et à revoir les maquettes organisationnelles définies jusqu'alors. Différents dispositifs transitoires sont mobilisés selon les besoins (pools de remplacement polyvalent ou spécifique pour les services de réanimation néonatale, néonatalogie, psychiatrie et dialyse ; heures majorées ; recours à l'intérim ; postes partagés ; fermeture de lits et services). Les responsables médicaux et paramédicaux d'équipes bénéficient de formations ou de coaching en management. La gouvernance impulse le travail en équipe sous différentes formes : temps dédié dans la plupart des services (par exemple : Réunions de fonctionnement en psychiatrie ; analyse d'événement indésirables en équipe), réflexion et mise en œuvre d'une synchronisation des temps médicaux et non médicaux (exemple : travail mené au bloc opératoire), 16 dossiers retenus pour 2023-2024 relatifs au projet AP-HM sur l'engagement collectif. 5 services ont obtenu le label qualité-sécurité institutionnel. Des équipes se sont engagées dans des labellisations ou certifications avec reconnaissance externe, témoin d'une reconnaissance de travail collectif : Certification NIDCAP en réanimation des nouveau-nés ; Label GRACE, pour la 4ème année consécutive, pour la réhabilitation améliorée après chirurgie décerné en chirurgie gynécologique, bariatrique et ORL. Un protocole de coopération médecin-orthophoniste est en place dans le cadre de bilan de déglutition fonctionnel. La gouvernance impulse et soutient des démarches spécifiques d'amélioration du travail en équipe. L'équipe de radiologie est accréditée, 4 praticiens sont accrédités et 2 équipes vont s'engager (ORL, néphrologie). Les connaissances et les compétences individuelles et collectives des équipes sont assurées : budget formation alloué au service, évaluation individuelle des professionnels, recherche de l'adéquation entre les missions et les compétences des professionnels. La plupart des équipes rencontrées s'inscrivent dans des démarches de formation avec des mises en situation : exercice de simulation vis-à-vis de complications post-opératoires, escape game sur les MHR, simulation de réanimation en néonatalogie, formation in situ en dialyse avec mise en situation, simulation de prise en charge des hématomes cervicaux suffocants en urgence au bloc opératoire etc... L'AP-HM promeut et soutient le recours au questionnement éthique par l'ensemble des acteurs. Les équipes de l'Hôpital de la Conception se sont emparées du sujet au-delà de l'espace éthique mis à la disposition des professionnels et des gouvernances des 4 sites de l'AP-HM. Les équipes sont sensibilisées et discutent de problèmes éthiques à l'occasion de réunions pluri professionnelles. Certains services animent des comités éthiques (en psychiatrie, en dialyse) afin d'offrir aux professionnels des espaces de réflexion. Les différents questionnements éthiques identifiés en équipe, n'ont pas donné lieu à un état des lieux partagé à l'échelle du site, avec l'ensemble des acteurs. Les représentants des usagers n'ont pas été associés à la réflexion éthique. L'AP-HM met en œuvre une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, concertée avec les instances représentatives des professionnels et reposant sur un questionnaire de satisfaction des professionnels mené mars 2024 (en cours d'analyse au moment de la visite). Cette politique se traduit à l'Hôpital de la Conception par des espaces temps de discussion collectives, des recherches de solutions visant à améliorer l'organisation du travail dans les unités et des dispositifs d'écoute pour un soutien psychologique. Des actions visant l'accueil et l'intégration des professionnels sont soulignées par les professionnels comme étant des éléments de qualité de vie professionnelle, ainsi que la bulle « bien-être » ou la bulle « allaitement ». Les professionnels de nuit peuvent se référer à l'encadrement paramédical mais aussi à l'encadrement médical. La gouvernance met en place des mesures de gestion des difficultés interpersonnelles et des conflits. L'AP-HM dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels elle peut être confrontée. La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est pilotée au niveau de l'AP-HM et déclinée sur le site de l'Hôpital de la

Conception avec une direction médico-administrative de crise, des entraînements réguliers assortis de RETEX. La prévention des atteintes aux personnes et aux biens est maîtrisée (plan de sécurisation à jour, responsables locaux de sécurité, accès protégés, professionnels formés aux règles de sécurité et équipés de matériels de protection : PTI pour tout le personnel en psychiatrie ; montre connectée pour l'encadrement de nuit ; alerte donnée par la police aux équipes de l'HAD). Les risques environnementaux et enjeux du développement durable sont maîtrisés ; Le projet d'établissement en cours de finalisation place l'écologie dans le soin et autour du soin comme un axe fort. Une organisation institutionnelle sur ces thématiques est en place, avec désignation de référent et d'un comité de pilotage « développement durable » sur le site de l'Hôpital de la Conception. Il en découle des actions se déclinant dans les domaines de la gestion des déchets, la maîtrise des énergies, le recyclage de l'eau (dialyse) et l'éco soin (gaz anesthésiants). Le circuit des déchets est conforme aux règles d'hygiène et de tri. La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l'enceinte de l'Hôpital de la Conception : numéro d'appel unique et connu des professionnels, chariots dédiés, accessibles et vérifiés, évaluation du dispositif. Les formations AFGSU ont repris après la période Covid. Des exercices de simulation sont menés dans les secteurs. L'AP-HM développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins qui se traduit à l'Hôpital de la Conception par une mobilisation des équipes dans la mise à jour des protocoles et maîtrise des bonnes pratiques (implication des instances du site, travail en équipe sur les actions d'amélioration des prises en charge de patients, mise à disposition de recommandation sous format adapté : pour exemple, algorithme de prise en charge du nodule surrénalien). Pour autant tous les secteurs n'ont pas réalisé d'évaluation de leur activité lors de revue de pertinence des admissions et des séjours. Le point de vue du patient est pris en compte dans le programme d'amélioration continue de la qualité ; cependant les professionnels rencontrés ne connaissent pas les avis et recommandations issues de la CDU de l'AP-HM ou du comité local des usagers. Les indicateurs qualité et sécurité des soins sont analysés, exploités et communiqués au niveau de l'AP-HM et de l'Hôpital de la Conception; les professionnels se sont appropriés ces indicateurs ou ceux spécifiques à leur service. Les événements indésirables liés aux soins sont analysés au travers d'un outil informatique de l'AP-HM piloté par le comité des vigilances et des risques, exploités et communiqués à l'Hôpital de la Conception. Les EIG sont déclarés et font l'objet d'une analyse approfondie. En revanche, les professionnels rencontrés ne connaissent pas les EIAS déclarés dans l'établissement, en lien avec leur secteur d'activité. L'accréditation des médecins est promue : 4 médecins de spécialités différentes ont une accréditation individuelle (chirurgie gynécologique, chirurgie plastique et réparatrice, chirurgie maxillo-faciale et imagerie médicale), soit 40% des services concernés sachant que certaines spécialités n'ont pas encore de programme d'accréditation d'équipe. L'accréditation en équipe est promue dans l'établissement : la chirurgie Urologique et la chirurgie ORL sont en cours d'accréditation. Le service d'imagerie médicale est déjà accrédité en équipe. Tous les médecins ou secteurs à risques, éligibles ne sont pas identifiés.

Table des Annexes

- Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche
- Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2024
- Annexe 3. Programme de visite

Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche

Type de structure	N° FINESS	Nom de l'établissement	Adresse
Établissement juridique	130786049	ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE	80 rue brochier 13005 Marseille 05eme FRANCE
Établissement principal	130783236	APHM-HOPITAL DE LA CONCEPTION	147 boulevard baille 13005 Marseille cedex 5 FRANCE
Établissement géographique	130806052	APHM-CMP	9 rue lafon 13006 MARSEILLE 06 FRANCE
Établissement géographique	130808546	CATTP DE LA CAPELETTE	9 rue lafon 13006 MARSEILLE 06 FRANCE

Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2024

Catégorie / Champs d'applicabilité / Donnée de profil	Valeur
Autorisations	
Urgences	
Existence d'un soignant d'accueil et d'orientation	Non
Si oui, l'accueil et l'orientation sont réalisés par IAO (infirmière d'accueil et d'orientation) ou par MAO (médecin d'accueil et d'orientation)	Non
Existence de Structure des urgences générales	Non
Existence de Structure des urgences pédiatriques	Non
Hospitalisation à domicile	
Présence d'une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7/7 (IDE se déplaçant au domicile)	Oui
Autorisation de Médecine en HAD	Oui
Autorisation d' Obstétrique en HAD	Oui
Autorisation de SMR en HAD	Non
Autorisation de Prise en charge du cancer en HAD	Non
Tout l'établissement	
Existence d'une permanence d'accès aux soins de santé (PASS) dans votre établissement	Oui
Existence d'une solution d'informatisation du circuit du médicament à la PUI	Oui
Existence d'Unité de préparation des médicaments de chimiothérapie anticancéreuse	Non
SAMU-SMUR	
Existence de SMUR général	Non
Existence de SMUR pédiatrique	Non
Existence d'Antenne SMUR	Non
Existence d'un SAMU	Non
Soins critiques	
Présence de service de Réanimation (y compris soins intensifs et surveillance continue)	Non
Présence de Réanimation enfant (hors néonatalogie)	Non

Présence d'Unité de soins intensifs en cardiologie (USIC)	Non
Présence d'Unité de surveillance continue (SC) adulte	Oui
Présence d'Unité de surveillance continue (SC) enfant	Non
Médecine	
Autorisation de Traitement de l'insuffisance rénale chronique (hors péritonéale) en centre	Oui
Autorisation de Traitement de l'insuffisance rénale chronique (péritonéale)	Non
Patient atteint d'un cancer	
Autorisation de Traitement des affections cancéreuses par chimiothérapie	Oui
Autorisation de Traitement des affections cancéreuses par radiothérapie (dont curiethérapie)	Oui
Chirurgie et interventionnel	
Autorisation de Chirurgie cardiaque	Non
Autorisation d'Activité interventionnelle en cardiologie	Non
Autorisation de Neurochirurgie	Non
Autorisation d'Activité interventionnelle en neurologie	Non
Autorisation d'Activité de greffe	Oui
Activité Urgences	
Urgences	
Nombre total de passages aux urgences dans l'année pour des patients de plus de 80 ans	0
Nombre de passages aux urgences générales	0
Nombre de passages aux urgences pédiatriques	0
SAMU-SMUR	
Nombre de Dossiers de Régulation Médicale (DRM)	0
Activité Hospitalière MCO	
Soins de longue durée	
Nombre de patients PEC durant l'année écoulée par une équipe mobile de gériatrie	0
Médecine	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Médecine	197
Chirurgie et interventionnel	

Nombre de lit en Hospitalisation complète en Chirurgie	149
Maternité	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Gynécologie-Obstétrique	104
Ambulatoire	
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Médecine	106
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Chirurgie	20
Nombre de places en hospitalisation partielle en Gynécologie-Obstétrique	22
Tout l'établissement	
Nombre de séances en hospitalisation partielle en Médecine	37,082
Enfant et adolescent	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Pédiatrie	0
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Pédiatrie	0
Patient âgé	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Gériatrie	0
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Gériatrie	0
Urgences	
Nombre de lit en UHCD	0
Activité Hospitalière SMR	
Soins Médicaux et de Réadaptation	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en SMR	0
Nombre de places en Hospitalisation partielle en SMR	0
Activité Hospitalière SLD	
Soins de longue durée	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en SLD	0
Activité Accident Vasculaires Cérébraux (AVC)	
Chirurgie et interventionnel	
Nombre de lits de l'Unité Neuro-Vasculaire (UNV)	0
Activité Hospitalière PSY	
Psychiatrie et santé mentale	
Nombre de lit en Psychiatrie générale en hospitalisation à temps plein	117

Nombre de lit en Psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation à temps plein	0
Nombre de lit en Psychiatrie en milieu pénitentiaire en hospitalisation à temps plein	0
Nombre Total de lit en Psychiatrie en hospitalisation à temps plein	117
Nombre de lit en Psychiatrie générale en hospitalisation de jour	56
Nombre de lit en Psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation de jour	0
Nombre de lit en Psychiatrie en milieu pénitentiaire en hospitalisation de jour	0
Nombre Total de lit en Psychiatrie en hospitalisation de jour	56
Nombre de CATTP en Psychiatrie générale	1
Nombre de CATTP en Psychiatrie infanto-juvénile	0
Nombre de CATTP en Psychiatrie en milieu pénitentiaire	0
Nombre Total de CATTP en Psychiatrie	1
Nombre de CMP en Psychiatrie générale	18,280
Nombre de CMP en Psychiatrie infanto-juvénile	0
Nombre Total de CMP en Psychiatrie	18,280
Sites opératoires et salles d'intervention	
Chirurgie et interventionnel	
Nombre total de salles (d'intervention ou d'exploration) des sites (calculé)	26
Ambulatoire	
Nombre de salles dédiées à la chirurgie ambulatoire	0
Activité Hospitalière HAD	
Hospitalisation à domicile	
Nombre total de patients pouvant être pris en charge simultanément en HAD	65

Annexe 3. Programme de visite

Nb	Méthode	Sous-méthode	Champs d'applicabilité	Description traceur
1	Patient traceur		Maternité Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
2	Patient traceur		Psychiatrie et santé mentale Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
3	Audit système			
4	Audit système			
5	Audit système			
6	Traceur ciblé			Prescription d'un patient intégrant, a minima, un Médicament à risque / antibiotique injectable / per os
7	Audit système			
8	Audit système			
9	Audit système			
10	Patient traceur		Psychiatrie et santé mentale Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé	

			Tout l'établissement	
11	Patient traceur		Médecine Hospitalisation à domicile Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
12	Patient traceur		Psychiatrie et santé mentale Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
13	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
14	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
15	Patient traceur		Maternité Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
	Patient		Chirurgie et interventionnel	

16	traceur		Ambulatoire Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
17	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
18	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
19	Patient traceur		Psychiatrie et santé mentale Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
20	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
	Patient traceur		Médecine Hospitalisation à domicile Enfant et adolescent	

21			Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
22	Patient traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
23	Patient traceur		Psychiatrie et santé mentale Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
24	Patient traceur		Psychiatrie et santé mentale Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
25	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
26	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé	

			Tout l'établissement	
27	Parcours traceur		Maternité Médecine Hospitalisation complète Adulte Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
28	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
29	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
30	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
31	Parcours traceur		Psychiatrie et santé mentale Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé	

			Tout l'établissement	
32	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Soins critiques Ambulatoire Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
33	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
34	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
35	Traceur ciblé			PSC
36	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Médecine Ambulatoire Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap	

			Programmé Tout l'établissement	
37	Traceur ciblé			EI
38	Traceur ciblé			ENDOSCOPE
39	Parcours traceur		Médecine Ambulatoire Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
40	Traceur ciblé			EI
41	Audit système			
42	Traceur ciblé			Prescription d'un patient intégrant, a minima, un Médicament à risque / antibiotique injectable / per os
43	Traceur ciblé			PSC
44	Traceur ciblé			PSC
45	Audit système			
46	Audit système			
47	Audit système			
48	Audit système			
49	Audit système			

50	Traceur ciblé			chimio
51	Traceur ciblé			PSL
52	Audit système			
53	Traceur ciblé			Prescription d'un patient intégrant, a minima, un Médicament à risque / antibiotique injectable / per os
54	Audit système			
55	Audit système			
56	Audit système			
57	Audit système			
58	Audit système			
59	Audit système			
60	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
61	Parcours traceur		Psychiatrie et santé mentale Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé	

			Tout l'établissement	
62	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
63	Parcours traceur		Médecine Soins critiques Ambulatoire Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
64	Patient traceur		Psychiatrie et santé mentale Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
65	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
66	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé	

			Tout l'établissement	
67	Parcours traceur		Maternité Médecine Ambulatoire Hospitalisation complète Adulte Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Patient en situation de précarité Programmé Tout l'établissement	
68	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
69	Traceur ciblé			PSL
70	Traceur ciblé			Prescription d'un patient intégrant, a minima, un Médicament à risque / antibiotique injectable / per os
71	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
72	Audit système			
	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Médecine Ambulatoire Hospitalisation complète	

73			Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
74	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
75	Patient traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
76	Audit système			
77	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
78	Audit système			
79	Audit système			
80	Patient traceur		Médecine Hospitalisation à domicile Enfant et adolescent Patient en situation de handicap	

			Programmé Tout l'établissement	
81	Audit système			
82	Traceur ciblé			ANTIBIOPROPHYLAXIE / PER OP
83	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
84	Parcours traceur		Médecine Hospitalisation à domicile Adulte Enfant et adolescent Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
85	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Maternité Hospitalisation complète Adulte Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	

Retrouvez tous nos travaux sur
www.has-sante.fr

